

1. У пацієнта діагностовано раптову зупинку кровообігу. Свідомість відсутня, дихання не визначається, пульс на сонній артерії не пальпується. На ЕКГ реєструються нерегулярні, неоднакової форми та амплітуди хвилі. Комплекс QRS, сегмент ST і зубець T не розпізнаються. Яке порушення серцевого ритму в цього пацієнта?

- A. Фібриляція передсердь без пульсу
- B. Фібриляція шлуночків
- C. AV-блокада без пульсу
- D. Безпульсова електрична активність
- E. Шлуночкова тахікардія без пульсу

2. Пацієнтці після зупинки кровообігу проводиться серцево-легенева реанімація, після виконання електричної дефібриляції на ЕКГ-моніторі з'явилися ознаки відновлення синусового ритму, проте пульсація на сонних та стегнових артеріях відсутні. Які подальші дії має виконати лікар?

- A. Повторити розряд дефібрилятора
- B. Продовжити масаж серця та штучну вентиляцію легень
- C. Припинити реанімаційну акцію
- D. Ретельно виміряти артеріальний тиск
- E. Ввести в/в 1 мг адреналіну

3. Яким антисептиком необхідно обробити ділянку навколо рани при пораненні?

- A. 90%-им розчином етилового спирту
- B. 40%-им розчином етилового спирту
- C. Розчином перекису водню
- D. Розчином фурациліну
- E. 70%-им розчином етилового спирту

4. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 62 роки. Діагностовано: розрив печінки (крововтрата - 1500 мл), закритий перелом обох кісток лівої гомілки. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ -14 балів, ЧД - 20/хв, SpO₂ - 96% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 5 л/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., ЧСС - 116/хв, Hb - 60г/л, еритроцити - $2,0 \cdot 10^{12}/л$, МНО - 1,2, ПТІ - 80%, фібриноген - 0,8 г/л. Чим повинна бути доповнена гемостатична терапія?

- A. Кріопреципітат
- B. Транексамова кислота 2 г/добу
- C. Тромбоконцентрат
- D. Транексамова кислота 3 г/добу

E. Концентрат протромбінового комплексу

5. Який критерій оцінки периферичної перфузії при проведенні медичного сортування за алгоритмом START дозволяє зарахувати постраждалого до 'червоної' категорії?

- A. >5 с
- B. >30 с
- C. <2 с
- D. >10 с
- E. >2 с

6. У пацієнта діагностовано раптову зупинку кровообігу. Свідомість відсутня, дихання не визначається, пульс на сонній артерії не пальпується. На ЕКГ реєструються нерегулярні, неоднакової форми та амплітуди хвилі. Комплекс QRS, сегмент ST і зубець T не розпізнаються. Яку першочергову дію має виконати лікар під час СЛР у цій ситуації?

- A. Внутрішньовенне введення атропіну
- B. Електричну дефібриляцію
- C. Зовнішній масаж серця
- D. Відновлення прохідності дихальних шляхів
- E. Внутрішньовенне введення адреналіну

7. Який відсоток кисню необхідно дати пацієнту під час проведення серцево-легеневої реанімації?

- A. Максимально можливий відсоток кисню
- B. 50% кисню
- C. 40% кисню
- D. Вентилювати необхідно атмосферним повітрям
- E. 80% кисню

8. Який основний патогенетичний механізм розвитку шоку в дітей?

- A. Порушення перфузії тканин
- B. Травма
- C. Коагулопатія
- D. Гіповолемія
- E. Зниження скоротливості міокарда

9. Що застосовують для лікування пацієнтів із бронхоспазмом, які зазнали токсичного впливу хлору?

- A. Аерозольні бронходилататори
- B. Киснево-гелієві суміші
- C. Магнію сульфат у формі спрею
- D. Седативні препарати
- E. Гірчичники

10. Які критерії включає алгоритм START при сортуванні постраждалих під час масових надходжень?

- A. Стан притомності, наявність та частота дихання, стан перфузії
- B. Стан притомності, наявність та частота дихання, стан перфузії, результати інструментальних досліджень
- C. Стан притомності, стан перфузії, результати лабораторних досліджень
- D. Швидкий огляд потерпілого, результати лабораторних та інструментальних досліджень
- E. Стан притомності, наявність та частота дихання, стан перфузії, результати лабораторних досліджень

11. У пацієнта зі штучним водієм ритму в серці виникла зупинка кровообігу та необхідність у дефібриляції. На якій безпечній відстані від корпусу кардіостимулятора потрібно розмістити електроди?

- A. Пацієнти із штучним водієм ритму не потребують електричної дефібриляції
- B. Один з електродів потрібно розмістити якнайближче до корпусу кардіостимулятора
- C. Між електродами дефібрилятора та корпусом штучного водія ритму має бути відстань не менше ніж 5 см
- D. Один з електродів потрібно встановити безпосередньо над корпусом кардіостимулятора
- E. Між електродами дефібрилятора та корпусом штучного водія ритму має бути відстань не менше ніж 8 см

12. У жінки віком 27 років із синдромом подовженого інтервалу QT виник пароксизм шлуночкової тахікардії типу пірует. Який препарат необхідно ввести у цьому разі?

- A. Лідокаїн
- B. Ізопреналін
- C. Аміодарон, прокаїнамід
- D. Метопролол
- E. Магнію сульфат

13. При обстеженні пацієнтки віком 24 роки зі скаргами на ниючий біль у животі, загальну слабкість, запаморочення та сонливість з'ясували, що загальний стан задовільний, основні показники життєдіяльності в межах норми. Згідно зі збором анамнезу за схемою SAMPLE,

відомо про скарги, відсутність алергії, постійний прийом медикаментів (фолієвої кислоти), останній прийом їжі - 3 год тому, причина виникнення болю в животі невідома. Які додаткові опитування необхідно провести для повноцінного збору анамнезу за шкалою SAMPLE?

- A. З'ясувати, коли було останнє вживання їжі або напоїв
- B. З'ясувати місце роботи пацієнтки та вплив шкідливих факторів
- C. Зібрати загальний алергологічний анамнез
- D. Зібрати інфекційний анамнез дитячого віку
- E. З'ясувати, чи вона не є вагітною, виявити супутні (перенесені) захворювання, травми

14. Чоловік віком 48 років, який лікувався в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. Об'єктивно спостерігається: зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочато компресію грудної клітини та вентиляцію легень. На ЕКГ-моніторі реєструється електрична активність без пульсу. Які подальші дії лікаря в цьому разі?

- A. Ввести в/в адреналін
- B. Ввести в/в аміодарон
- C. Ввести в/в атропін після 3-го розряду
- D. Негайна дефібриляція
- E. Ввести в/в атропін

15. На трамвайній зупинці дівчина знепритомніла. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, пульс на сонній артерії не визначається. Негайно розпочато комплекс серцево-легеневої реанімації. Що з нижченаведеного свідчить про ефективність реанімаційних заходів?

- A. Зниження температури тіла
- B. Перелом ребер
- C. Аспірація вмістом шлунка
- D. Розширені зіниці
- E. Пульсація на сонній артерії

16. Укажіть дозування адреналіну під час проведення реанімаційних заходів новонародженому.

- A. 0,1-0,3 мг/кг
- B. Від 1 до 3 мг/кг розчину 1:1000
- C. 0,5-1,0 мл
- D. 0,01-0,03 мкг/кг
- E. 0,01 до 0,03 мг/кг

17. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 42 роки. Діагностовано: розрив селезінки (крововтрата - 2000 мл), закритий перелом лівої стегнової кістки, геморагічний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 13 балів, ЧД - 22/хв, SpO₂ - 95% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 5 л/хв, АТ - 70/50 мм рт. ст., ЧСС - 126/хв, Hb - 55г/л, еритроцити - $1,5 \cdot 10^{12}$ /л, МНО - 1,8, ПТІ - 60%, фібриноген - 1г/л. Яка тактика лікаря на ранньому госпітальному етапі?

- A. Транексамова кислота 3 г/добу, плазма свіжозаморожена
- B. Проведення трансфузії донорської крові
- C. Трансфузія свіжозамороженої плазми
- D. Концентрат протромбінового комплексу, транексамова кислота 3 г/добу
- E. Кріопреципітат 4 дози, транексамова кислота 3 г/добу

18. Унаслідок ДТП водій отримав проникаючу травму грудної клітки. Візуалізується рана, через яку проходить повітря під час вдиху та видиху. Загальний стан потерпілого тяжкий, аускультативно - дихальні шуми на стороні поранення відсутні. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Клапанний, напружений пневмоторакс
- B. Гемоторакс
- C. Спонтанний пневмоторакс
- D. Відкритий пневмоторакс
- E. Закритий пневмоторакс

19. Жінка віком 63 роки доставлена до приймального відділення після ураження блискавкою. Під час огляду: свідомість ясна, шкіра рожева, суха, зовнішніх ушкоджень немає, але спостерігається ціаноз губ, акроціаноз. АТ - 150/90 мм рт. ст., пульс 104/хв, ЧД - 18/хв. До якого відділення необхідно шпиталізувати пацієнтку?

- A. Опікового
- B. Виписати додому
- C. Кардіологічного
- D. Неврологічного
- E. Реанімаційного

20. Пацієнту під час серцево-легеневої реанімації проведено інтубацію трахеї. Яким стане співвідношення компресій та штучних вдихів?

- A. Кожну 6-ту секунду, асинхронно

- B. 5:1
- C. 3:1
- D. 15:2
- E. 30:2

21. Жінці віком 47 років зворотною причиною раптової зупинки серця є гіпоксія. Які дії має виконати лікар для усунення цього патологічного стану?

- A. Відновити прохідність дихальних шляхів складним надгортанним пристроєм або інтубація, вентилювати на кожну 5 с, під'єднати 100%-ий кисень
- B. Вентилювати за показниками капнографа, дотримуючись 35-45 мм рт. ст.
- C. Забезпечити оксигенотерапію 100%-им киснем 15 л/хв за допомогою назальних канюль
- D. Забезпечити оксигенотерапію 100%-им киснем 15 л/хв за допомогою нереверсивної маски
- E. Відновити прохідність дихальних шляхів орофарингеальною трубкою, вентилювати на кожну 15 с, під'єднати 100%-ий кисень

22. У відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги надійшла дворічна дівчинка. Діагностовано раптову зупинку кровообігу, розпочато реанімаційні заходи та грудні компресії. Визначте правильну глибину натискання на грудну клітку пацієнта, враховуючи вікові особливості.

- A. 1/4 передньо-заднього розміру грудної клітки
- B. 1/5 передньо-заднього розміру грудної клітки
- C. 1/6 передньо-заднього розміру грудної клітки
- D. 1/3 передньо-заднього розміру грудної клітки
- E. 1/2 передньо-заднього розміру грудної клітки

23. Жінка віком 53 роки шпиталізована до реанімаційного відділення із симптомами гострого інфаркту міокарда, через 10 хв раптово виникла зупинка серцевої діяльності та дихання. негайно розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які подальші дії лікаря в цьому разі?

- A. Введення аміодарону 300 мг в/в
- B. Негайна дефібриляція
- C. Введення адреналіну 1 мг в/в
- D. Оцінка ЕКГ-ритму

Е. Визначення рівня глюкози крові

24. Чоловіка віком 35 років після травми грудної клітки шпиталізовано у тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: порушення свідомості, АТ - 80/40 мм рт. ст., пульс аритмічний 100-120/хв, тони серця не прослуховуються, ціаноз, аускультативно дихання ліворуч відсутнє, наявна асиметрія грудної клітки, тимпаніт, девіація трахеї вправо. Який патологічний стан у пацієнта?

- А. Гемоторакс ліворуч
- В. Забій головного мозку
- С. Напружений пневмоторакс ліворуч
- Д. Інфаркт міокарда
- Е. Перелом груднини

25. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги прибула на виклик з приводу утоплення 5 осіб, що евакуювалися за допомогою катера. У 3 із них виникло утоплення та була проведена успішна серцево-легенева реанімація. Із наявних симптомів: виражена задишка у стані спокою, ціаноз, пінисте мокротиння та загальна слабкість. Який вид утоплення виник у пацієнтів?

- А. Справжній
- В. Синкопальний
- С. Блідий
- Д. Асфіктичний
- Е. Гіпервентиляційний

26. Під час медичного сортування у потерпілого при обстеженні визначено стан свідомості за шкалою ком Глазго - 8 балів, пульс на периферійних судинах відсутній. До якої сортувальної групи слід перевести потерпілого?

- А. Жовтої
- В. Фіолетової
- С. Червоної
- Д. Чорної
- Е. Зеленої

27. Потерпілий на підприємстві отримав термічний опік II ступеня тяжкості, уражено 20% поверхні тіла. Госпіталізація на який рівень надання комбустіологічної допомоги показана?

- А. -
- В. Амбулаторне лікування під наглядом лікаря-хірурга або лікаря-комбустіолога
- С. На другий рівень
- Д. На перший рівень
- Е. На третій рівень

28. У чоловіка з цукровим діабетом поступово з'явилися почуття голоду, загальна слабкість, гіпергідроз, психомоторне збудження, втрата свідомості. АТ - 130/80 мм рт. ст., тахікардія. Яке лабораторне дослідження необхідно першочергово провести у цьому разі?

- А. Загальний аналіз сечі
- В. Визначення вмісту глюкози крові
- С. Загальний аналіз крові
- Д. Комп'ютерна томографія головного мозку
- Е. Люмбальна пункція

29. Пацієнт знаходиться в стані клінічної смерті, на ЕКГ-моніторингу визначається фібриляція шлуночків. Укажіть, який антиаритмічний засіб і після якої неуспішної спроби дефібриляції доречно застосувати.

- А. Метопролол, після третьої неефективної спроби
- В. Лідокаїн, після першої неефективної спроби
- С. Метопролол, після другої неефективної спроби
- Д. Аміодарон, після першої неефективної спроби
- Е. Аміодарон, після третьої неефективної спроби

30. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги приїхала на місце ДТП. Під час оцінки місця подій помічають потерпілого з деформованим передпліччям. До якої категорії за системою медичного сортування належить цей пацієнт?

- А. Червоної
- В. Жовтої
- С. Чорної
- Д. Фіолетової
- Е. Зеленої

31. Під час проведення розширених реанімаційних заходів у пацієнта визначалося п'ять дефібриляційних ритмів поспіль. Яке дозування аміодарону необхідно ввести після п'ятої послідовної дефібриляції?

- А. 900 мг в/в
- В. 150 мг в/в
- С. 450 мг в/в
- Д. 600 мг в/в
- Е. 300 мг в/в

32. Чоловік віком 28 років після ДТП скаржиться на головний біль, нудоту та блювання. Не пам'ятає, що було під час ДТП. Відомо, що втрачав свідомість на 2 хв. Об'єктивно спостерігається: брадикардія, гіпотензія, шкіра бліда, анізокорія, сухожилкові рефлексі знижені. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Струс головного мозку легкого ступеня
- B. Струс головного мозку важкого ступеня
- C. Струс головного мозку середнього ступеня
- D. Закритий переломи черепа
- E. Субарахноїдальний крововилив

33. Новонароджена дівчинка від других передчасних пологів, із гестаційним віком 33-34 тижні, масою тіла 2000 г. Об'єктивно спостерігається: дихання відсутнє, ЧСС - 60/хв, виражений генералізований ціаноз, на подразники не реагує, реакція зіниць на світло слабо виражена. Які дії насамперед має виконати лікар?

- A. Розпочати інфузійну терапію
- B. Провести тактильну стимуляцію
- C. Забезпечити тепловий режим
- D. Розпочати реанімаційні заходи
- E. Оцінити за шкалою Апгар

34. У жінки віком 30 років, що надійшла до приймального відділення, раптово виникла зупинка серцевої діяльності. Медичною бригадою розпочато серцево-легеневу реанімацію, що триває 20 хв. Назвіть об'єктивну причину для припинення реанімаційних заходів.

- A. Ціаноз шкіри верхніх кінцівок
- B. Ціаноз шкіри нижніх кінцівок
- C. Поява ознак біологічної смерті
- D. Перелом ребер та груднини
- E. Аспірація вмістом шлунка

35. Під час виконання протоколу розширених заходів реанімації, один із рятувальників помітив різке підняття PetCO_2 . Про що це може свідчити?

- A. Прогностично неблагоприємна ознака з відновлення спонтанного кровообігу
- B. Неефективне проведення компресій грудної клітки
- C. Некоректне проведення вентиляції
- D. Відновлення спонтанного кровообігу
- E. Зміщення інкубаційної трубки в правий бронх

36. У жінки віком 52 роки після успішних реанімаційних заходів ЧСС - 36/хв, АТ -

80/50 мм рт. ст. Що необхідно призначити пацієнтці насамперед?

- A. Ввести в/в 20 мг дексаметазону
- B. Налагодити в/в інфузію адреналіну
- C. Ввести в/в 150 мг аміодарону
- D. Ретельний електрокардіографічний моніторинг
- E. Атропіну сульфат в/в у дозі 500 мкг

37. Яку допомогу необхідно надати потерпілому з проникаючим пораненням грудної клітки, що спричиняє відкритий пневмоторакс?

- A. Заклеїти місце поранення пов'язкою з плівки
- B. Провести плевральну пункцію за Бюлау
- C. Здійснити декомпресію грудної клітки
- D. Накласти асептичну пов'язку на рану
- E. Проводити оксигенотерапію потерпілому

38. Які ознаки вказують на наявність у потерпілого напруженого пневмотораксу?

- A. Блискавично наростаюча задишка, порушення гемодинаміки, відхилення трахеї вбік
- B. Ослаблення везикулярного дихання на стороні ураження
- C. Біль у грудній клітці, тахікардія
- D. Розвиток підшкірної емфіземи
- E. Виділення кров'янистого кольору пухирців повітря з рани

39. У пацієнта після зупинки кровообігу проводять серцево-легеневу реанімацію. Під час накладання електродів дефібрилятора на ЕКГ-моніторі визначаються широкі комплекси QRS із частотою 20-30/хв, що не супроводжується наявністю пульсації сонних та стегнових артерій. Які подальші дії має виконати лікар?

- A. Продовжити СЛР та якнайшвидше ввести в/в 1 мг адреналіну
- B. Ввести в/в 300 мг аміодарону
- C. Припинити реанімаційні заходи
- D. Ввести в/в 500 мкг атропіну сульфату
- E. Виконати електричну дефібриляцію

40. Чоловік під час ДТП вдарився грудною кліткою об кермо автомобіля. Протягом 1 години наростали задишка, загальна слабкість. При аускультатії легень з правого боку - дихання відсутнє, з лівого - везикулярне. Пульс - 110/хв, ритмічний. АТ

- 110/70 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A. Правобічний гемоторакс
- B. Забій грудної клітки праворуч
- C. Перелом ребер праворуч
- D. Кардіальний шок
- E. **Правобічний закритий пневмоторакс**

41. У пацієнта діагностовано раптову зупинку кровообігу. На ЕКГ реєструється фібриляція шлуночків. Проводиться комплекс заходів базової підтримки життя. Які лікарські засоби необхідно ввести після третьої послідовної дефібриляції?

- A. **Адреналін та аміодарон**
- B. Атропін та аденозин
- C. Адреналін та атропін
- D. Атропін та аміодарон
- E. Адреналін та аденозин

42. Чоловіку віком 49 років із відновленням спонтанного кровообігу, у якого зворотною причиною раптової зупинки кровообігу була гіповолемія, проводиться інфузійна терапія. При повторному огляді аускультативно - вологі хрипи, частота дихання - 4 за 10 сек, синусова тахікардія на моніторі, АТ - 80/40 мм рт. ст. Які подальші дії в наданні допомоги цьому пацієнту?

- A. **Припинити проведення інфузійної терапії**
- B. Ввести препарати нітрогліцерину
- C. Зменшити дозу інфузії
- D. Інгаляційно дати сальбутамол
- E. Ввести норадреналін в/в

43. Що є альтернативним лікарським засобом кордарону при протипоказах до його застосування?

- A. **Лідокаїн**
- B. Дигоксин
- C. Магнію сульфат
- D. Прокаїнамід
- E. Метапролол

44. Які показники визначають церебральний перфузійний тиск у дітей різних вікових груп?

- A. Рівень калію та глюкози крові
- B. Рівень глюкози у крові та внутрішньочерепний тиск
- C. Рівень лактату крові та внутрішньочерепний тиск
- D. **Середній артеріальний тиск та внутрішньочерепний тиск**

E. рН та рівень глюкози крові

45. Який шлях введення адреналіну гідрохлориду під час зупинки серцевої діяльності?

- A. Внутрішньотрахеальний
- B. **Внутрішньовенний**
- C. Не показаний під час зупинки серцевої діяльності
- D. Внутрішньосерцевий і внутрішньотрахеальний
- E. Внутрішньосерцевий

46. При сортуванні пацієнта за системою JumpSTART спостерігається, що дитина не має зовнішніх кровотеч та не дихає, після відновлення прохідності дихальних шляхів дихання не з'явилося. Які подальші дії має виконати лікар?

- A. Залишити його, оскільки він належить до категорії 'чорний'
- B. Зробити 5 рятувальних вдихів
- C. Встановити назофарингіальний повітропровід
- D. Класифікувати його за категорією 'червоної'
- E. **Перевірити пульс**

47. У пацієнта на ЕКГ-моніторі зареєстровано фібриляцію шлуночків та негайно проведено дефібриляцію розрядом 150 Дж. Які подальші дії лікаря?

- A. Виконати прекардіальний удар
- B. Оцінити ритм та перевірити пульс
- C. **Негайно розпочати СЛР 30:2**
- D. Провести повторну дефібриляцію 200 Дж без перерви
- E. Негайно ввести 1 мг адреналіну в/в

48. У пацієнта віком 36 років множинні переломи ребер, гостра дихальна недостатність. Під час проведення інтубації трахеї та переходу на штучну вентиляцію легень спостерігається збільшення ціанозу, зниження артеріального тиску. Яка причина виникнення цього стану?

- A. Тромбоемболія легеневої артерії
- B. **Напружений пневмоторакс**
- C. Пневмонія
- D. Ішемічний інсульт
- E. Гіпертонічний криз

49. Укажіть складники, що входять до алгоритму збору анамнезу SAMPL

- A. Алергія, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання

- їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища
- В.** Симптоми, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища
- С.** Симптоми, алергія, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища
- Д.** Симптоми, алергія, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища
- Е.** Симптоми, алергія, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини

50. До травмованого внаслідок ДТП водія викликали бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Об'єктивно спостерігається: крепітація кісткових фрагментів II-V ребер, шкіра обличчя - ціанотична, виражена емфізема на шиї та обличчі, вени на шиї напружені, дихання з лівого боку не вислуховується, тони серця - приглушені, АТ - 140/80 мм рт. ст. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А.** Перелом ребер і закритий пневмоторакс
- В.** Перелом груднини
- С.** Відкритий пневмоторакс
- Д.** Гемоторакс
- Е.** Закритий пневмоторакс

51. У шестимісячної дитини під час огляду спостерігається: виражена дихальна недостатність, синюшний носогубний трикутник у спокої, значні виділення з носа, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. Дитина неспокійна, плаче, спостерігалось апное протягом 4 с. Сатурація - 87%, ЧД - 40/хв, допоміжна участь мускулатури в акті дихання. Яка тактика лікаря в цьому разі?

- А.** Помістити дитину під кисневий ковпак
- В.** негайно ввести парацетамол для зняття жару
- С.** Санація ВДШ, налагодження подачі кисню
- Д.** Постановка носових канюль, налагодження подачі кисню
- Е.** Забезпечення нейтрального положення голови, подача кисню через маску

52. До відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні звернулися батьки із п'ятирічною дитиною зі скаргами на раптове погіршення її стану. При огляді

дитини: ЧСС - 196/хв, АТ - 100/55 мм рт. ст., аускультативно - над легенями дихання везикулярне, без хрипів, сатурація - 97%, свідомість ясна, комплекси QRS на ЕКГ регулярні, тривалістю 0,06 с. З чого слід розпочати лікування дитини?

- А.** З електричної кардіоверсії
- В.** Із внутрішньовенного введення аміодарону
- С.** Із в/в введення аденозину
- Д.** Із вагусних маневрів
- Е.** Із внутрішньовенного введення верапамілу

53. Чоловік віком 60 років скаржиться на головокружіння, загальну слабкість, оніміння правої верхньої кінцівки. Об'єктивно спостерігається: асиметрія обличчя, слабкість правої руки, порушення мовлення. Який тест необхідно провести для оцінки ймовірного інсульту в пацієнта?

- А.** GCS
- В.** APGAR
- С.** FAST
- Д.** AVPU
- Е.** MARCH

54. Десятирічній дитині з важким загостренням бронхіальної астми призначили системний глюкокортикостероїд. Яку дозу преднізолону необхідно призначити пацієнту?

- А.** 40 мг
- В.** 70 мг
- С.** 35 мг
- Д.** 140 мг
- Е.** 30 мг

55. Із чого починається серцево-легенева реанімація у пацієнтів з обструкцією дихальних шляхів стороннім тілом на догоспітальному етапі?

- А.** Компресій
- В.** Вентиляцій
- С.** Огляду ротової порожнини
- Д.** Абдомінальних поштовхів
- Е.** 5-ти рятівних вдихів

56. До відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні звернулися батьки із п'ятирічною дитиною зі скаргами на раптове погіршення її стану. При огляді дитини: ЧСС - 196/хв, АТ - 70/35 мм рт. ст., аускультативно - над легенями дихання везикулярне, без хрипів, сатурація - 93%, свідомість пригнічена (13 балів за шкалою

ком Глазго), комплекси QRS на ЕКГ регулярні, тривалістю 0,06 с. З чого розпочати лікування дитини?

- А. В/в введення аміодарону
- В. Вагусних маневрів
- С. В/в введення сульфату магнію
- Д. Електричної кардіоверсії
- Е. В/в введення верапамілу

57. Який 'золотий стандарт' діагностики ТЕЛА?

- А. УЗД серця
- В. Рентгеноскопія органів грудної клітки
- С. Комп'ютерна томографічна ангіографія
- Д. Спірографію
- Е. Бронхоскопію

58. Який діапазон балів за шкалою ком Глазго необхідний для постановки діагнозу: кома?

- А. 3-8
- В. 10-15
- С. 0
- Д. 0-2
- Е. 9-10

59. Під час проведення СЛР у дитини 8 років, якою буде енергія першого розряду для дефібриляції у разі наявності на моніторі фібриляції шлуночків або шлуночкової тахікардії без пульсу?

- А. 0,5 Дж/кг
- В. 4 Дж/кг
- С. 1 Дж/кг
- Д. 6 Дж/кг
- Е. 2 Дж/кг

60. У чоловіка під час прийому їжі раптово розвинулися напад кашлю, задишка, ціаноз шкірних покривів, втрата свідомості. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Стороннє тіло дихальних шляхів
- В. Тромбоемболія легеневої артерії
- С. Інфаркт міокарда
- Д. Пневмоторакс
- Е. Інфаркт легені

61. Який алгоритм первинного огляду потерпілого використовується на місці ДТП?

- А. Шкала APACHE
- В. Шкала ком Глазго
- С. Шкала SOFA
- Д. Шкала AVPU
- Е. CABCDE

62. На місці ДТП - чоловік віком 35 років, без свідомості, пульс на сонних артеріях не визначається, зіниці широкі, самостійно перестав дихати за кілька хвилин до приїзду карети швидкої медичної допомоги. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Клінічна смерть
- В. Агонія
- С. Термінальна пауза
- Д. Преагонія
- Е. Біологічна смерть

63. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 34 роки. Діагностовано: розрив селезінки (крововтрата - 2000 мл). Геморагічний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 20/хв, SpO₂ - 95% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 7 л/хв, АТ - 70/40 мм рт. ст., ЧСС - 126/хв, Hb - 55г/л, еритроцити - 1,5г/л. У пацієнта: група крові В (III) Rh (-). На станції переливання крові еритроцитарних компонентів крові В (III) Rh (-) немає. Яка тактика лікаря на ранньому госпітальному етапі?

- А. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові АВ (IV) Rh (+)
- В. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові А (II) Rh (-)
- С. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові О (I) Rh (+), дексаметазон 8 мг
- Д. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові О (I) Rh (-)
- Е. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові АВ (IV) Rh (-)

64. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 37 років. Діагностовано: правобічний гемоторакс (крововтрата - 1000 мл), закритий перелом лівої стегнової кістки, травматичний шок II ст. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 28/хв, SpO₂ - 94% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 8 л/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., ЧСС - 116/хв, Hb - 70г/л, еритроцити - $2,2 \cdot 10^{12}/л$. Що повинна включати інтенсивна терапія контролю пошкоджень?

- А. Профілактика й усунення летальної тріади
- В. Профілактика венозного тромбоемболізму

- С. Профілактика гіпертермії і метаболічного алкалозу
- Д. Профілактика синдрому жирової емболії
- Е. Профілактика гіпертермії, гіперкоагуляції та алкалозу

65. На хімічному підприємстві під час техногенної катастрофи відбулося руйнування ємності з токсичною речовиною. Для найефективнішого надання допомоги найбільшій кількості потерпілих використовується система медичного сортування 'START'. Що передбачає ця система насамперед?

- А. Оцінку можливості самостійно пересуватися
- В. Оцінку рівня свідомості та психічного стану
- С. Заповнення реєстраційних форм про надзвичайну ситуацію
- Д. Оцінку самостійного дихання і спонтанного кровообігу
- Е. Зупинку кровотечі потерпілим, які цього потребують

66. Яке твердження є правильним щодо потерпілих третьої сортувальної групи?

- А. Надається медична допомога в необхідному об'ємі після надання допомоги потерпілим II категорії
- В. Надається медична допомога в останню чергу
- С. Надається необхідна медична допомога після пацієнтів/потерпілих II та IV категорії
- Д. Мають найвищий пріоритет, наявні ресурси ЗОЗ повинні бути першочергово спрямовані на надання медичної допомоги цій групі
- Е. Надається медична допомога в необхідному об'ємі після надання допомоги потерпілим I категорії

67. Який показник не враховується під час оцінки стану за шкалою Апгар?

- А. М'язовий тонус
- В. Температура тіла
- С. Частота скорочень серця
- Д. Колір шкіри
- Е. Стан зовнішнього дихання

68. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 43 роки з діагнозом: перелом правої стегнової кістки. Із анамнезу відомо: пацієнтка впродовж 3-

х місяців приймає варфарин 5 мг/добу. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 15 балів, ЧД - 18/хв, SpO₂ - 98% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 3 л/хв, АТ - 135/90 мм рт. ст., ЧСС - 106/хв, Нв - 90г/л, еритроцити - $2,8 \cdot 10^{12}/л$, МНО - 3,5, ПТІ - 40%. Яка тактика лікаря на ранньому госпітальному етапі?

- А. Вітамін К, концентрат протромбінового комплексу
- В. Транексамова кислота 3 г/добу
- С. Транексамова кислота 2 г/добу, кальцію хлорид 1000 мг
- Д. Транексамова кислота 2 г/добу, трансфузія еритроцитарного компоненту крові
- Е. Тромбоконцентрат, транексамова кислота 3 г/добу

69. Яка кількість балів за шкалою ком Глазго необхідна для постановки діагнозу: смерть мозку?

- А. 1
- В. 2
- С. 0
- Д. 6
- Е. 3

70. Укажіть критичне раннє ускладнення краш-синдрому.

- А. Коагулопатія
- В. Поліорганна недостатність
- С. Сепсис
- Д. Гіперкаліємія
- Е. Ниркова недостатність

71. До потерпілого внаслідок електротравми викликано бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Під час огляду спостерігається: пацієнт непритомний, самостійне дихання та пульс відсутні. негайно розпочато проведення серцево-легеневої реанімації. На кардіомоніторі - фібриляція шлуночків. Проведено 2 дефібриляції. Під час третьої переоцінки ритму - фібриляція шлуночків. Якою буде подальша тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- А. Епінефрин 1 мг в/в, електрична кардіоверсія
- В. Електрична дефібриляція і продовження серцево-легеневої реанімації
- С. Продовжувати серцево-легеневу реанімацію

D. Епінефрин 1 мг в/в, аміодарон 600 мг в/в

E. Електрична дефібриляція, епінефрин 1 мг в/в, аміодарон 300 мг в/в

72. Чоловік віком 78 років доставлений бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги у відділення реанімації та інтенсивної терапії через 30 хвилин після раптового виникнення порушення мовлення та слабкості у правій верхній та нижній кінцівках. Під час огляду виявлено параліч та гіперестезію правої сторони, позитивний симптом Бабінського праворуч, нерозбірливе мовлення. На комп'ютерній томографії голови показує гіперденсивність лівої середньої мозкової артерії та відсутність ознак внутрішньочерепної кровотечі. Стан пацієнта швидко покращується після початку фармакотерапії, а слабкість повністю зникає. Який із нижченаведених препаратів, найімовірніше, був застосований?

A. Варфарин

B. Альтеплаза

C. Гепарин

D. Ривароксабан

E. Празугрель

73. До жінки віком 57 років викликали бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Зранку, на тлі повного благополуччя, виник сильний біль в правій половині грудної клітки, з'явилась задишка. Об'єктивно спостерігається: ЧД – 30/хв, грудна клітка - асиметрична, перкуторно - тимпаніт праворуч, аускультативно - відсутність дихальних шумів з правого боку. Із анамнезу відомо, що 5 років тому лікувався з приводу туберкульозу легень. Який патологічний стан виник у пацієнта?

A. Забій грудної клітки

B. Гострий інфекційний плеврит

C. Відкритий пневмоторакс

D. Патологічний перелом ребра праворуч

E. Спонтанний пневмоторакс

74. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 24 роки. Діагностовано: перелом кісток тазу, закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ -14 балів, ЧД - 20/хв, SpO₂ - 96% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 6 л/хв, АТ - 85/55 мм рт. ст., ЧСС - 106/хв, Hb - 75г/л, еритроцити - $2,3 \cdot 10^{12}$ /л. Які компоненти інтенсивної

терапії контролю пошкоджень є доцільними на ранньому госпітальному етапі?

A. Ліберальний режим інфузійної терапії, максимально швидка зупинка кровотечі, кінцева хірургічна корекція пошкоджень

B. Активне зігрівання потерпілого, інфузійна терапія, раннє використання компонентів крові, рання корекція коагулопатії

C. Максимально швидка зупинка кровотечі, кінцева хірургічна корекція пошкоджень

D. Ліберальний режим інфузійної терапії

E. Ліберальний режим інфузійно-трансфузійної терапії

75. Які ознаки характерні для гіперкаліємії та реєструється на ЕКГ-моніторі при краш-синдромі?

A. Вузькі комплекси QRS (більш ніж 0,12 с), надшлуночкові екстрасистоли, тахікардія

B. Випадіння комплексів QRS, наявність пікових Т-хвиль

C. Вузькі комплекси QRS (більш ніж 0,12 с), відсутність Р-хвиль, наявність пікових Т-хвиль

D. Широки комплекси QRS (більш ніж 0,12 с), відсутність Р-хвиль, наявність пікових Т-хвиль

E. Бігеменія, відсутність Р-хвиль, наявність пікових Т-хвиль

76. Семирічній дитині з масою тіла 25 кг із ознаками абдомінальної інфекції діагностовано септичний шок. Введено 1250 мл збалансованих ізотонічних кристалоїдних розчинів впродовж 2 годин. Проводиться інфузія норадреналіну зі швидкістю 1 мкг/кг/хв. При цьому АТ - 60/30 мм рт. ст. Який препарат необхідно застосувати для подальшої корекції гемодинаміки?

A. Гідрокортизону гемісукцинат 1-2 мг/кг маси тіла

B. Застосувати колоїдні плазмозамінні розчини

C. Розпочати терапію адреналіну

D. Застосувати інфузію фенілефрину (мезатону)

E. Збільшити швидкість введення норадреналіну

77. Укажіть обсяг допомоги при черепно-мозковій травмі на догоспітальному етапі.

- A. Підтримання САТ на рівні 100 мм рт. ст. у молодих пацієнтів та 110 мм рт. ст. у пацієнтів похилого віку, сатурації не менше 90%, капнографії в межах 35-40 мм рт. ст.
- B. Інфузійна терапія - 20 мл/кг/год
- C. Транспортування пацієнта на жорстких ношах із піднятим ножним кінцем
- D. Підтримання темпу діурезу не менше ніж 150 мл на год
- E. Призначення діуретиків

78. Чоловік віком 36 років отримав травму голови, відомо що втрачав свідомість на 5-10 хв. На момент огляду скарги на нудоту, блювання, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: розсіяна мікровогнищева неврологічна симптоматика, наявні забої м'яких тканин голови. Який метод обстеження необхідно виконати пацієнту для встановлення діагнозу?

- A. Електроенцефалографію
- B. Рентгенографію черепа
- C. Комп'ютерну томографію головного мозку
- D. Ехоенцефалографію
- E. Ангіографію судин головного мозку

79. Через який проміжок часу можна припинити реанімаційні заходи трирічній дитині у зв'язку з їх неефективністю?

- A. 30-45 хв
- B. 20-25 хв
- C. 5-10 хв
- D. 3-5 хв
- E. 10-15 хв

80. Як розрахувати ЦПР (центральный перфузійний тиск) при закритій черепномозковій травмі?

- A. ЦПТ = середній артеріальний тиск – внутрішньочерепний тиск
- B. ЦПТ = середній артеріальний тиск + 1/2 пульсового
- C. ЦПТ = діастолічний тиск – внутрішньочеревний тиск
- D. ЦПТ = систолічний тиск + 1/3 пульсового
- E. ЦПТ = систолічний тиск + 1/2 пульсового

81. Жінку віком 45 років шпиталізовано до лікарні після ДТП. Об'єктивно спостерігається: свідомість - ступор, пульс

- 66/хв, АТ - 160/90 мм рт. ст., анізокорія, мимовільні рухи в лівих кінцівках обмежені. Сухожильні рефлекси S>D, симптом Бабінського ліворуч, ригідність м'язів потилиці, позитивний симптом Керніга. На краніограмах - перелом правої тім'яної кістки, ліквор - із домішками крові. Який вид черепно-мозкової травми у пацієнта?

- A. Струс головного мозку
- B. Забій м'яких тканин голови
- C. Забій головного мозку
- D. Стиснення головного мозку
- E. Дифузне аксональне ураження головного мозку

82. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує чоловіка віком 42 роки до лікарні, який з метою суїциду випив 50 г хлорофосу, розвівши його в склянці з водою. Стан пацієнта різко погіршився: виникла брадикардія - 42/хв, слинотеча, слюзотеча, над легенями вологі поодинокі різнокаліберні хрипи. Який лікарський засіб необхідно застосувати, щоб стабілізувати стан пацієнта?

- A. Еуфілін 2,4%
- B. Атропін сульфат 0,1%
- C. Адреналін гідрохлорид 0,1%
- D. Фізіологічний розчин 0,9%
- E. Хлористий кальцій 10%

83. Під час медичного сортування виявлено, що потерпілий не може самостійно пересуватися, не співпрацює з медичним персоналом, дезорієнтований, ЧД - 30/хв, пульс на периферіях визначається. До якої сортувальної групи належить пацієнт?

- A. Фіолетової
- B. Червоної
- C. Чорної
- D. Зеленої
- E. Жовтої

84. У чоловіка віком 23 роки після ДТП виявлено переломом правої стегнової кістки в середній третині. Лікар екстреної (швидкої) медичної допомоги наклав тракційну шину Дітеріхса. З якою метою лікар здійснив цю маніпуляцію?

- A. Щоб кінцівка не заважала при транспортуванні
- B. З метою відновлення фізіологічного положення кінцівки

- С. Попередження жирової емболії кістковим мозком
- D. Попередження травмування судин, нервів та м'яких тканин**
- Е. Зменшення больових відчуттів у потерпілого

85. Яке положення тіла необхідно надати пацієнту із діагнозом: повітряна емболія?

- A. Положення змінюється в залежності від тяжкості стану
- B. Повернути на правий бік
- C. Повернути на живіт
- D. Не можна змінювати положення
- E. Повернути на лівий бік**

86. У дитини на ЕКГ-моніторі зареєстровано шлуночкову тахікардію без пульсу. Яку першочергову дію має виконати лікар під час СЛР у цій ситуації?

- A. Проведення кардіоверсії енергією 4 Дж/кг
- B. Проведення дефібриляції енергією 8 Дж/кг
- C. Проведення кардіоверсії енергією 1 Дж/кг
- D. Проведення дефібриляції енергією 4 Дж/кг**
- E. Проведення дефібриляції енергією 1 Дж/кг

87. Диспетчер скерував бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги до місцевого нафтопереробного підприємства, звідки надійшло повідомлення про вибух паливного резервуару та численних потерпілих. Прибувши на місце виклику, працівники бригади виявили 18 потерпілих осіб із травмами різного ступеня тяжкості. Згідно з яким алгоритмом необхідно провести медичне сортування потерпілих?

- A. START**
- B. SAMPLE
- C. JumpSTART
- D. CABCODE
- E. ABCDE

88. Укажіть вид травми, яка включає декілька пошкоджень у межах однієї анатомо-функціональної ділянки.

- A. Поєднана
- B. Множинна**
- C. Комбінована
- D. Ізольована
- E. Травматизм

89. При проведенні розширених реанімаційних заходів на ЕКГ-моніторі виявлено ритм, який може дати пульс. При оцінці: пульс на центральній артерії наявний, збігається з монітором, ЧСС - 140/хв, самостійне дихання відсутнє, SpO₂ - не визначається. Які наступні дії має виконати лікар?

- A. Подати кисень 100% через носові канюлі
- B. Відновити прохідність дихальних шляхів орофарингеальним повітроводом
- C. Подати 100% кисень через нереверсивну маску
- D. Екстубувати пацієнта
- E. Вентиляція мішком АМБУ 1 раз на кожні 5 с**

90. Який препарат необхідно ввести пацієнту в разі отруєння опіоїдами?

- A. Кофеїн
- B. Натрію гідрогенкарбонат
- C. Кальцію глюконат
- D. Налоксон**
- E. Флумазенил

91. У пацієнта після пункції і катетеризації підключичної вени значно погіршився загальний стан. Об'єктивно: задишка, SpO₂ - 78%, ЧСС - 120/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., діагностований напружений пневмоторакс на боці пункції. Які невідкладні дії має виконати лікар?

- A. негайно перевести пацієнта на ШВЛ і розпочати інфузію норадреналіну
- B. Інтубацію трахеї, оксигенотерапію
- C. негайно перевести пацієнта на ШВЛ
- D. Провести пункцію і дренирування плевральної порожнини на боці пневмотораксу**
- E. Оксигенотерапію

92. Чоловік віком 37 років під час їжі раптово підвівся на ноги схопившись за шию. У нього розвинулися напад кашлю та задишка, ціаноз шкірних покривів. Діагностовано стороннє тіло дихальних шляхів. Яку невідкладну допомогу потрібно надати пацієнтові у цьому разі?

- A. Прийом Геймліха**
- B. Штучна вентиляція легень
- C. Закритий масаж серця
- D. Потрійний прийом Сафара
- E. Прекардіальний удар

93. У жінки віком 25 років після укусу бджоли через 20 хвилин розвинувся анафілактичний шок. Який препарат необхідно ввести насамперед?

- A. Дексаметазон
- B. Епінефрин
- C. Димедрол
- D. Норепінефрин
- E. Фамотидин

94. Чоловіку віком 67 років проводяться розширені реанімаційні заходи. Із анамнезу відомо, що пацієнт проходить сеанси гемодіалізу. Рівень калію в плазмі крові становить 7 ммоль/л. Який препарат та в якому дозуванні необхідно ввести пацієнту з кардіопротективною дією?

- A. Кальцію глюконат 10% 30 мл
- B. Лідокаїн 1 мг/кг в/в
- C. Адреналін 0,1% 1 мл в/в
- D. Магнію сульфат 2 г в/в
- E. Аміодарон 150 мг

95. До відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні звернулися батьки із п'ятирічною дитиною зі скаргами на раптове погіршення її стану. При огляді дитини: ЧСС - 196/хв, АТ - 100/55 мм рт. ст., аускультативно над легенями дихання везикулярне, без хрипів, сатурація 97%, свідомість ясна, комплекси QRS на ЕКГ регулярні, тривалістю 0,06 с. Вагусні маневри - без успіху. Яким повинен бути наступний крок у лікуванні дитини?

- A. В/в введення аденозину
- B. Електрична кардіоверсія
- C. В/в введення аміодарону
- D. В/в введення верапамілу
- E. В/в введення сульфату магнію

96. У чоловіка віком 85 років раптово з'явився біль у грудній клітці, задишка, покашлювання. Об'єктивно спостерігається: здуття шийних вен, у легенях визначається коробковий перкуторний звук, у нижніх відділах з правого боку - притуплення, акцент II тону над легеневою артерією. На обох ногах - варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. У нижній третині стегна правої ноги припухлість, відзначається локальна гіперемія. Рентгенографічно: у нижній частині правої легені - затемнення. Яке ускладнення, найбільш вірогідно, виникло у пацієнта?

- A. Інфаркт міокарда
- B. Тромбоемболія легеневої артерії

- C. Пневмонія
- D. Пневмоторакс
- E. Астматичний стан

97. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано жінку віком 64 років. Із анамнезу відомо: 20 хв. тому раптово втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 8 балів, лівобічна геміплегія, ЧД - 7/хв, SpO₂ - 85% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 8 л/хв, АТ - 160/110 мм рт. ст., ЧСС - 102/хв. Планується проведення комп'ютерної томографії головного мозку. Які першочергові заходи необхідно провести на ранньому госпітальному етапі?

- A. Інтубацію трахеї, респіраторну підтримку, транспортування для проведення нейровізуалізації
- B. Встановлення ларингеальної маски, ШВЛ мішком Амбу, транспортування для проведення нейровізуалізації
- C. Оксигенотерапію, транспортування для проведення нейровізуалізації
- D. Негайне транспортування пацієнтки для проведення нейровізуалізації
- E. Стабілізацію стану впродовж 48 годин

98. Які ритми належать до недефібриляційних при зупинці кровообігу в педіатрії відносяться?

- A. Асистолія, безпульсова електрична активність, брадикардія <60/хв
- B. Фібриляція шлуночків, безпульсова шлуночкова тахікардія
- C. Фібриляція шлуночків, фібриляція предсердь
- D. Асистолія, безпульсова електрична активність, фібриляція шлуночків
- E. Асистолія, безпульсова шлуночкова тахікардія, брадикардія <60/хв

99. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 59 років. Діагностовано: правобічний гемоторакс (1000 мл), закритий перелом правого стегна. Геморагічний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 15 балів, ЧД - 26/хв, SpO₂ - 95% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 6 л/хв, АТ - 90/55 мм рт. ст., ЧСС - 120/хв, Hb - 65г/л, еритроцити - $2,1 \cdot 10^{12}/л$. Яке співвідношення компонентів крові необхідно ввести потерпілому на ранньому госпітальному етапі?

- A. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 1:1
- B. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 2:2
- C. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 3:1
- D. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 1:2
- E. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 1:3

100. У пацієнта віком 57 років, який лікувався в стаціонарі з приводу інфаркту міокарда, виникла зупинка серця. Після проведення реанімаційних заходів у пацієнта з'явився пульс, артеріальний тиск - 60/20 мм рт. ст. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнту для подальшої стабілізації стану?

- A. Інфузію глюкокортикостероїдів
- B. Гемотрансфузію
- C. Серцеві глікозиди
- D. Продовжити болюсне введення адреналіну
- E. Інфузію допаміну

101. У п'ятирічної дитини діагностовано анафілаксію. Яку дозу адреналіну необхідно ввести пацієнтці?

- A. 150 мкг в/м
- B. 100 мкг в/м
- C. 500 мкг в/м
- D. 300 мкг в/м
- E. 200 мкг в/м

102. У жінки віком 40 років, на 25 тиждень вагітності, раптово погіршився стан із втратою свідомості. Констатовано зупинку кровообігу та дихання. З анамнезу: гіпертонічна хвороба. Що може сприяти ефективній серцево-легеневій реанімації в цій ситуації?

- A. Підняти нижні кінцівки для централізації кровообігу
- B. Відтиснути ручним способом вагітну матку ліворуч
- C. Залишити пацієнтку горизонтально з валиком під лопатками
- D. Повернути тулуб вагітної жінки на правий бік

E. Підняти головний кінець на 30° для кращого доступу

103. У дівчини віком 21 рік на відпочинку після укусу бджоли через 5 хв посилився біль у ділянці укусу. Загальний стан різко погіршився: виникло відчуття нестачі повітря, жару, запаморочення, шум у вухах. Спостерігається: блідість шкіри, акроціаноз, холодний липкий піт по тілу, артеріальний тиск - 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан виник у дівчини?

- A. Гіпоглікемічна кома
- B. Гіперглікемічна кома
- C. Гостре порушення мозкового кровообігу
- D. Анафілактичний шок
- E. Непритомність

104. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано дитину віком 14 років із масою тіла 48 кг у непритомному стані із судомами, що тривають. Забезпечено прохідність дихальних шляхів та внутрішньовенний доступ. Яку максимальну разову внутрішньовенну дозу діазепаму необхідно призначити дитині в цьому разі?

- A. 12 мг
- B. Діазепам можна застосовувати тільки після 16 років
- C. 24 мг
- D. 5 мг
- E. 10 мг

105. Дитина через 30 хвилин після початку гри в теніс раптово втратила свідомість. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий діабет, тяжка форма. Об'єктивно спостерігається: шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Пульс - 80/хв, ритмічний. АТ - 110/70 мм рт. ст. ЧД - 28/хв, ритмічне. Менінгеальні симптоми відсутні. Який патологічний стан виник у дитини?

- A. Гіпоглікемічна кома
- B. Лактацидотична кома
- C. Гіперглікемічна кома
- D. Діабетична кетоацидотична кома
- E. Діабетична гіперосмолярна кома

106. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує пацієнта з гострим коронарним синдромом. Лікар раптово помітив, що пацієнт не реагує на подразники. На ЕКГ-моніторі ритм, який може дати пульс. Укажіть першочергові дії лікаря?

- A. Ввести 1 мг адреналіну в/в
- B. **Перевірити пульс на сонній артерії**
- C. Ввести гліцерил тринітрат 0,4 мг сублінгвально
- D. Розпочати інфузійну терапію
- E. Провести негайну дефібриляцію

107. Чоловіка віком 52 роки збив автомобіль на пішохідному переході. Скаржиться на виражений біль у правому стегні. Об'єктивно спостерігається: патологічна рухомість на рівні середньої третини стегна. Пляма крові на одязі та під потерпілим швидко збільшується. Які дії потрібно виконати в цьому разі?

- A. Провести тампонування рани та здійснити транспортну іммобілізацію
- B. **Виконати дії, які зменшать кровотечу, накласти турнікет максимально високо**
- C. Накласти тиснучу пов'язку та ввести знеболювальні препарати
- D. Здійснити прямий тиск на рану та накласти компресійну пов'язку
- E. Здійснити прямий тиск на судину, що кровоточить та накласти турнікет на 5-7 см вище за рану

108. У жінки віком 52 роки, яка хворіє на епілепсію, розвинувся великий судомний напад тривалістю 2 хв. Через 3 хв після нападу свідомість не відновилася, виникли повторні тоніко-клонічні судоми. Яка тактика надання допомоги на догоспітальному етапі?

- A. Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія, пропофол 1,5мг/кг в/в
- B. Пульсоксиметрія, тіопентал натрію 5 мг/кг в/в
- C. Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія, кетамін 2 мг/кг в/в
- D. Оцінити перфузію, діазепам 0,1 мг/кг в/в
- E. **Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія, діазепам 0,3 мг/кг в/в**

109. Унаслідок техногенної ядерної катастрофи, доставлено чоловіка 40 років до відділення інтенсивної терапії. У чоловіка скарги на помірно виражений головний біль, запаморочення, однократна блювота. Об'єктивно у потерпілого: ясна свідомість, орієнтується у місці та часі, шкіра звичайного кольору, пульс - 80/хв, тони серця звучні, АТ - 120/80 мм рт. ст.,

аускультативно - дихання везикулярне, температура тіла - 36,2^oC. Дані індивідуального дозиметру дорівнюють 1,2 Гр. Встановіть попередній діагноз?

- A. Гостра променева хвороба V ступеня тяжкості
- B. Гостра променева хвороба IV ступеня тяжкості
- C. Гостра променева хвороба II ступеня тяжкості
- D. **Гостра променева хвороба I ступеня тяжкості**
- E. Гостра променева хвороба III ступеня тяжкості

110. Під час транспортування пацієнта віком 50 років із болем за грудниною на кардіомоніторі з'явився такий ритм: шлуночкова тахікардія Яку дію повинен виконати медичний працівник?

- A. Провести дефібриляцію 200 Дж
- B. Перевірити пульс на сонній артерії за відсутності, провести синхронізовану кардіоверсію з енергією розряду 150 Дж
- C. Перевірити пульс на сонній артерії за відсутності, провести дефібриляцію розрядом 150 Дж
- D. Провести дефібриляцію 150 Дж
- E. **Перевірити пульс на сонній артерії за відсутності, провести дефібриляцію розрядом, передбаченим мануалом дефібрилятора**

111. Чоловік унаслідок ДТП отримав проникаюче поранення грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: неспокійний, наявний виражений акроціаноз, задишка, дихання поверхневе, прискорене, АТ-100/60 мм рт. ст. Виявлено під час огляду обмеження рухливості ураженої половини грудної клітки. Як необхідно транспортувати пацієнта з цією патологією?

- A. Лежачи на животі з опущеними ногами
- B. Лежачи на боці з піднятою верхньою частиною тулуба
- C. Транспортування протипоказане
- D. Лежачи на спині з піднятими ногами
- E. **Лежачи на спині з піднятою верхньою частиною тулуба**

112. У палаті інтенсивної терапії проводять реанімаційні заходи восьмирічній дитині з масою тіла 30 кг. На кардіомоніторі - ознаки фібриляції шлуночків серця. Якою

має бути енергія першого розряду дефібрилятора?

- A. 4 Дж /кг = 120 Дж
- B. 2 Дж /кг = 60 Дж
- C. 1 Дж /кг = 30 Дж
- D. 8 Дж /кг = 240 Дж
- E. 200 Дж

113. П'ятирічна дитина під час прийому їжі несподівано закашлялася, з'явилося утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: періодичний кашель, утруднений видих, відставання грудної клітки в акті дихання. Аускультативно вислуховується послаблене дихання над легеньми праворуч, перкуторно - тимпаніт, рентгенологічно - зміщення органів середостіння вліво. Який метод лікування необхідно виконати пацієнту?

- A. Езофагоскопія
- B. Бронхоскопія, видалення стороннього тіла
- C. Протинабрякові ендоларингеальні інгаляції
- D. Трахеотомія
- E. Торакотомія

114. Під час якого патологічного стану знижується ефективність введеного адреналіну гідрохлорид для відновлення серцевої діяльності?

- A. Гіпоксії
- B. Метаболічного алкалозу
- C. Респіраторного алкалозу
- D. Метаболічного ацидозу
- E. Кислотно-лужний стан не має значення

115. У дворічної дитини після отруєння таблетками 'від мігрені' визначається загальмованість, брадикардія, А-V блокада, артеріальна гіпотензія, бронхоспазм. Який препарат необхідно призначити пацієнті для лікування?

- A. Добутамін
- B. Серцеві глікозиди
- C. Атропину сульфат
- D. Допамін
- E. Норадреналін

116. На яку кількість часу можна припинити закритий масаж серця з метою інтубації трахеї?

- A. 5 с
- B. 20 с
- C. 10 с
- D. 30 с

E. 15 с

117. Який стан не належить до зворотних причин смерті?

- A. Гіпокаліємія
- B. Тромбоемболія легеневої артерії
- C. Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку
- D. Гіпоксія
- E. Напружений пневмоторакс

118. Який термін накладання джгута на нижню кінцівку під час артеріальної кровотечі пацієнту?

- A. 90 хв
- B. 150 хв
- C. 60 хв
- D. 120 хв
- E. 30 хв

119. У семирічної дитини спостерігається виражена слабкість, млявість, бліді шкірні покриви, набряки на нижніх кінцівках. Раптово втратила свідомість. Дихання спонтанне, ЧД - 18/хв, на ЕКГ-моніторі брадикардія з елевацією зубця Т. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Гіпоглікемія
- B. Гіперглікемія
- C. Гіперкальціємія
- D. Гіперкаліємія
- E. Гіпокаліємія

120. У чоловіка віком 46 років на ЕКГ-моніторі діагностована фібриляція шлуночків. Які першочергові реанімаційні заходи необхідно надати пацієнту?

- A. Електричну дефібриляцію
- B. Введення допаміну
- C. Введення лідокаїну гідрохлориду
- D. Введення аміодарону
- E. Введення адреналіну гідрохлориду

121. У жінки віком 35 років шпиталізованої до приймального відділення, раптово виникла зупинка серцевої діяльності. На ЕКГ-моніторі реєструється фібриляція шлуночків. негайно розпочато дефібриляцію. Укажіть силу першого розряду дефібрилятора.

- A. 150 Дж біфазним дефібрилятором
- B. 360 Дж біфазним дефібрилятором
- C. 200 Дж біфазним дефібрилятором
- D. 250 Дж біфазним дефібрилятором
- E. 150 Дж монофазним дефібрилятором

122. Який об'єм інфузійної терапії кристалідами необхідно ввести дитині під час анафілаксії?

- A. 10 мл/кг
- B. 100 мл/кг
- C. 50 мл/кг
- D. 30 мл/кг
- E. 500-1000 мл

123. Яке твердження є правильним при розподілі потерпілих другої сортувальної групи у відділенні екстреної (швидкої) медичної допомоги під час масового надходження?

- A. Потерпілі, що знаходяться в критичному стані та потребують негайного виконання заходів/маніпуляцій, які рятують життя
- B. Потерпілі, стан яких стабільний, надання допомоги може бути відкладено на тривалий час без загрози для життя
- C. Потерпілі, які мають сумнівний прогноз щодо успішності лікування
- D. Потерпілі, що знаходяться у некритичному стані та не потребують негайного виконання заходів/маніпуляцій, які рятують життя
- E. Потерпілі, надання допомоги яким може бути відкладено на декілька годин без загрози для життя

124. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 32 роки. Діагностовано: закритий перелом правого і лівого стегна, розрив селезінки. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 16/хв, SpO₂ - 98% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 5 л/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., ЧСС - 112/хв, Hb - 40г/л, еритроцити - 1,6г/л. Планується проведення масивної трансфузії компонентів крові. Який об'єм компонентів крові необхідно ввести потерпілому на ранньому госпітальному етапі?

- A. Заміна 25% об'єму циркулюючої крові за 3-4 год
- B. Заміна 20% об'єму циркулюючої крові за 3-4 год
- C. Трансфузія 2 одиниць за 1 год
- D. Заміна 50% об'єму циркулюючої крові за 3-4 год
- E. Трансфузія 5 одиниць протягом 24 год

125. За якою шкалою визначається стан свідомості пацієнта на догоспітальному етапі?

- A. AVPU
- B. ETHANE
- C. ATMIST
- D. TRAUMA
- E. SAMPLE

126. Чоловік віком 40 років під час споживання шашлику раптово вибіг із-за столу, почав метушитися обхоплювати себе руками за шию. На запитання присутніх відповісти нічого не може, при вдиху відзначається інспіраторна задишка. Друзі розпочали проводити прийоми Геймліха, однак звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла не вдалося. Потерпілий різко зблід, почав втрачати свідомість. Яка подальша тактика?

- A. Негайно ввести ларингеальну маску
- B. Негайно провести інтубацію трахеї
- C. Негайно провести трахеостомію
- D. Дістати стороннє тіло пальцями
- E. Негайно провести конікотомію

127. Які дії насамперед має виконати лікар пацієнту із зареєстрованою на ЕКГ асистолією?

- A. Штучне дихання, закритий масаж серця
- B. Внутрішньовенне введення гідрокарбонату натрію
- C. Інфузію поліглюкіну
- D. Введення кортикостероїдів
- E. Введення beta-адреноблокаторів

128. Пацієнту віком 72 роки констатовано раптову зупинку кровообігу та розпочато розширені реанімаційні заходи. Більше 40 хвилин реанімаційних заходів у пацієнта спостерігається стійка асистолія, усі зворотні причини раптової зупинки кровообігу виключені. Показник СО₂ нижче 10 мм рт. ст. Визначте подальшу тактику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- A. Проведення електричної кардіоверсії
- B. Проведення реанімаційних заходів упродовж 40 хв, зважаючи на стійку асистолію
- C. Припинення реанімаційних заходів
- D. Переривання реанімаційних заходів на декілька хвилин
- E. Проведення дефібриляції 120 Дж

129. Жінка віком 27 років годину тому послизнулася на вулиці і впала лівим боком

на бордюр. Самостійно прийшла додому, але стан погіршувався і чоловік викликав бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Під час огляду лікаря пацієнтка притомна, шкірні покриви бліді, вологі, холодні. Пульс на променевій артерії не визначається. АТ - 80/40 мм рт. ст. ЧСС - 120/хв. Дихання везикулярне над усією поверхнею грудної клітки. ЧД - 18/хв. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- A. Закрита черепно-мозкова травма
- B. Внутрішня кровотеча, геморагічний шок
- C. Спонтанний пневмоторакс
- D. Перелом тазу
- E. Забій грудної клітки

130. Чоловіку віком 47 років, що постраждав унаслідок ДТП викликали бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Об'єктивно спостерігається: ЧД - 35/хв, права сторона грудної клітки участі в акті дихання не бере, вени шиї - розширені, аускультативно дихальні шуми праворуч не вислуховуються. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Гемопневмоторакс
- B. Забій грудної клітки, ускладнений емфіземою органів середостіння
- C. Відкритий пневмоторакс
- D. Перелом ребер справа
- E. Напружений пневмоторакс

131. Який патологічний тип дихання розвивається у пацієнтів під час діабетичної (кетоацидотичної) коми?

- A. Біота
- B. Куссмауля
- C. Тахіпноє
- D. Брадипноє
- E. Чейн-Стокса

132. Яке лікування суправентрикулярної тахікардії із нестабільною гемодинамікою у дітей?

- A. Негайна дефібриляція
- B. Ввести аміодарон
- C. Негайна кардіоверсія
- D. Ввести АТФ
- E. Ввести допамін

133. При наданні допомоги дитині з тяжким нападом бронхіальної астми (первинна маніфестація) всі етапи медикаментозної терапії були неефективні. Виберіть препарат запасу для лікування даного невідкладного стану, шлях та дозу введення.

- A. Дексаметазон 0,6 мг/кг в/м або в/в
- B. Метилпреднізолон 2 мг/кг в/в струминно
- C. Еуфілін 2,4% 6 мг/кг за 10 хвилин в/в
- D. Магnezія сульфат 25% 40 мг/кг за 20-60 хвилин в/в
- E. Сальбутамол 100 мкг (1 інгаляція) протягом 5 хв

134. Який антидот необхідно застосувати під час отруєння грибами, що містять фалотідини і аманітини (бліда поганка)?

- A. Атропін
- B. Налоксон
- C. Прозерин
- D. Бензилпеніцилін
- E. Натрію тіосульфат

135. Яка кількість балів за шкалою ком Глазго необхідна для постановки діагнозу: кома I?

- A. 8
- B. 3
- C. 15
- D. 10
- E. 1

136. З поля, обробленого отрутохімікатами, доставлено чотирирічну дитину. Свідомість сплутана, відмічається гіперсалівація та бронхорея, зіниці вузькі. Який препарат необхідно використати як антидот у цьому разі?

- A. Адреналін
- B. Хромосмон
- C. Унітіол
- D. Прозерин
- E. Атропін

137. Хлопчик народився в стані важкої асфіксії. ЧСС - 80/хв, дихання аритмічне, поодинокі дихальні рухи, дифузний ціаноз шкіри, знижений тонус м'язів. Лікар вирішив приступити до реанімаційних заходів. Яке положення повинна займати голова новонародженої дитини під час надання первинних реанімаційних заходів?

- A. Голова нахилена вперед
- B. Голова повернута вправо
- C. Голова сильно закинута назад
- D. Голова повернута вліво
- E. Голова злегка закинута назад

138. Які показники включає трикутник педіатричної оцінки?

- A. Зовнішній вигляд, дихання, кровообіг

- В. Частота серцевих скорочень, дихання, колір шкіри
- С. Свідомість, частота серцевих скорочень, колір шкіри
- Д. Артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, колір шкіри
- Е. Свідомість, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск

139. Семирічна дитина після перегріву на сонці пірнула у морську воду. Її витягнули з води через 4 хв. Шкіра бліда, самостійне дихання відсутнє, пульс на сонній артерії не визначається. Які невідкладні дії у цьому разі?

- А. Покликати батьків
- В. Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- С. Викликати екстрену (швидку) медичну допомогу
- Д. Знайти рятівника на пляжі
- Е. Виконати прекардіальний удар

140. При проведенні медичного сортування на місці дорожньо-транспортної пригоди, працівник бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, виявив 2-х 'чорних' потерпілих, 2-х 'червоних' та 1 'жовтого' потерпілого. Кого потрібно госпіталізувати в першу чергу?

- А. 'Червоних'
- В. 'Білих'
- С. 'Зелених'
- Д. 'Жовтих'
- Е. 'Чорних'

141. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 62 роки. Діагностовано: розрив печінки. Геморагічний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 15 балів, ЧД - 18/хв, SpO₂ - 96% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 5 л/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., ЧСС - 116/хв, Нb - 60г/л, еритроцити - $1,8 \cdot 10^{12}/л$. Показники коагулограми: МНО - 2,8, ПТІ - 50%. У пацієнтки: група крові А (II) Rh (+). На станції переливання крові одноступенної плазми немає. Яка тактика лікаря на ранньому госпітальному етапі?

- А. Трансфузія плазми свіжозамороженої В (III) і транексамова кислота 2г в/в
- В. Трансфузія плазми свіжозамороженої В (III), тромбоконтрату і транексамової кислоти 1 г в/в
- С. Трансфузія плазми свіжозамороженої В (III) в/в

Д. Транексамова кислота 3 г, плазма свіжозаморожена О (I) в/в

Е. Трансфузія плазми свіжозамороженої АВ (IV) в/в

142. Унаслідок вибуху на хімічному заводі є загиблі та поранені, понад 50 осіб з опіками, механічними травмами та отруєннями. Укажіть основні елементи, які передбачає лікувально-евакуаційне забезпечення населення у цьому разі.

- А. Сортування, надання медичної допомоги, евакуацію
- В. Сортування, відновлення, рятування
- С. Сортування, евакуацію, лікування
- Д. Ізоляцію, рятування, відновлення
- Е. Надання медичної допомоги, евакуацію, ізоляцію

143. Хлопчика, що хворіє на цукровий діабет протягом 10 років, шпиталізовано у зв'язку зі швидким погіршенням стану: загальна слабкість, поліурія, полідипсія, нудота, блювання, загальмованість, сонливість. Спостерігається: дихання Куссмауля, запах ацетону у видихнутому повітрі. У сечі наявна значна кількість цукру та кетонів тіл. Яке ускладнення цукрового діабету, найімовірніше, виникло у пацієнта?

- А. Гіпоглікемічна кома
- В. Гіперглікемічна кома
- С. Кетоацидотична кома
- Д. Печінкова кома
- Е. Лактоацидотична кома

144. Яку функцію виконує лідер бригади, що першою прибула на місце події з масовим ураженням людей?

- А. Медичного координатора
- В. Сортувальника
- С. Відповідального за розгортання медичного пункту
- Д. Відповідального за транспорт
- Е. Відповідального за вчасне прибуття додаткових служб

145. Після спортивної травми потерпілий скаржиться на біль у ділянці основи носа. Пальпація виявила чутливість стінок носових ходів і рухомість носових кісток. Носові ходи виповнені кров'яними згустками. Яка невідкладна допомога?

- А. Холод на ділянку носа, дренаж гематоми носової перегородки (за необхідності), контроль болю

- В. Транспортування до клініки
- С. Холод на ділянку носа
- Д. Тампонада носових ходів
- Е. Репозиція уламків, контроль болю

146. У жінки віком 46 років, незважаючи на проведену дезінтоксикаційну терапію з приводу отруєння етиленгліколем, уже другу добу спостерігаються: анурія, добовий діурез <50 мл, пастозність обличчя, калій плазми крові - 7,5 ммоль/л, наявні екстрасистולי на ЕКГ. Який із методів еферентної терапії буде ефективним по щодо елімінації калію з плазми?

- А. Гравітаційний
- В. Фільтраційний
- С. Перфузійний
- Д. Діалізний
- Е. Сорбційний

147. Працівник меблевої фабрики, працюючи за столярним станком, через необережність отримав різану рану плеча в середній третині із сильною кровотечею. Колега накладає турнікет з метою зупинки кровотечі. Яке правильне місце накладання турнікета в цьому разі?

- А. Безпосередньо над радою, що кровить
- В. У середній третині плеча
- С. Максимально високо на плечі
- Д. Нижче за рану на 5-7 см при знятому одязі
- Е. На 5-7 см вище ніж рана при знятому одязі

148. У чоловіка віком 73 років на тлі гострого тромбофлебиту лівої стегнової вени з'явилися болі в правій половині грудної клітки, які посилюються при глибокому вдиху та кашлі, кровохаркання. Праворуч, у нижніх відділах, вислуховується шум тертя плеври. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Правосторонній сухий плеврит
- В. Тромбоемболія легеневої артерії
- С. Правосторонній ексудативний плеврит
- Д. Пневмонія
- Е. Правосторонній пневмоторакс

149. У пацієнта із травмою грудної клітки проводиться апаратна ШВЛ. На манометрі реєструється збільшення тиску на вдиху до 50 см вод. ст. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- А. Розвиток геморагічного шоку

- В. Немає приводів для хвилювань, це нормальні параметри для вентиляції на етапі транспортування
- С. Розвиток пневмотораксу
- Д. Прогресування черепно-мозкової травми
- Е. Розвиток внутрішньочеревної кровотечі

150. У десятирічного хлопчика із діагнозом: бронхіальна астма з інтермітуючим перебігом, відзначається напад задухи середнього ступеня тяжкості. Якому препарату слід надати перевагу на початковому етапі невідкладної терапії?

- А. Сальбутамолу
- В. Фліксотиду
- С. Адреналіну
- Д. Норадреналіну
- Е. Інталу